

第二章 医学伦理学的基本伦理与规范体系

1. 医学道德一般指医务生活中的道德现象和道德关系，可简称为“医德”。
2. “伦”是中国词源中的类、辈、关系、次序，“理”为道理、原理、条理、法则。
3. “伦理”一词源于西方，我们接受的是西方的词义。伦理是指人际关系的法则。
4. 伦理学：伦理学（ethics）又称道德哲学，是对人类道德生活进行系统思考和研究的一门科学，是现代哲学的学科分支，如前所述、伦理与道德同义而通用。
5. 医学伦理学：是一门研究医学道德的科学。
6. 医学伦理学研究的对象：通过对医德现象的全面研究，揭示医德现象所表现的医德关系的各种矛盾及其变化发展的规律性。
7. 医德关系具体包括如下四个方面：

（1）医务人员与病人之间的关系。

这是最基本的关系，是医患之间服务与被服务的关系；医者处于主导地位；

（2）医务人员之间的关系。

（3）医务人员、卫生部门与社会之间的关系。

（4）医务人员与医学科学发展之间的关系。

医学伦理学的内容：

（1）医德理论

（2）医德规范

（3）医德实践

（4）医德难题

传统医德

（1）仁爱救人、赤诚济世的事业准则

（2）清廉正直、不图钱财的道德品质

（3）虚心好学、刻苦钻研的学习作风

（4）认真负责、一丝不苟的服务态度

（5）不畏权贵、忠于医业的献身精神

（6）不断总结、勇于创新的精神

时间线

（1）1946年，制订了《纽伦堡法典》，制定了关于人体实验的基本原则，“一是必须有利于社会，二是应该符合伦理道德和法律观点”；

（2）1948年，世界医学会颁布了《医学伦理学日内瓦协议法》；

（3）1949年，世界医学会通过《世界医学会国际医德守则》；

（4）1953年7月，国际护士会制定了《护士伦理学国际法》；

（5）1964年，通过了《赫尔辛基宣言》，制定了关于指导人体实验研究的重要原则，强调了人体实验必须知情同意。

（6）1968年8月，通过《悉尼宣言》，确定了死亡的道德责任和器官移植道德原则

（7）1972年10月，通过了《齿科医学伦理的国际原则》，作为每位齿科医生的指南

（8）1975年10月，通过了《东京宣言》，规定《关于对拘留犯和囚犯给予折磨、虐待、非人道的对待惩罚时，医师的行为准则》

（9）1977年在夏威夷召开的第六届世界精神病学大会，通过了关于精神病医生道德原则的《夏威夷宣言》

（10）1981年，世界医学大会通过了《病人权利宣言》

生命伦理学首先由美国的波特（Potter. V·R）使用，他对生命伦理学定义如下：“利用生命科学以改善人们生命质量的事业，同时有助于我们确定的目标，更好地理解人和世界的本质。因此，它是生存的科学，有助于人们对幸福和创造性生命开出处方”。

生命理论的主要观点

（一）生命神圣观

1、概述：

含义：强调人的生命价值至高无上，人的生命神圣不可侵犯。

产生的基础：

（1）医学活动本身的内在要求

（2）自然科学和医学科学及文艺复兴赋予的动力

2、对生命神圣观的评价：

（1）历史意义：

从道德的角度强化了医学宗旨；

为医学道义理论的形成以及发展奠定了思想基础；

（2）局限性

缺乏人类成熟的理性基础；

缺乏辨正性（忽视生命质量和价值、重视个体而忽视整体）；

（二）生命质量观与生命价值观

1、产生的历史条件

（1）医学科技的进步：现代医学科学技术的发展和应用，为人类有效、符合道德的干预生命提供技术保障

（2）强烈的社会需求：人口问题成为社会的焦点问题

2、含义：

（1）生命质量观是指人的生命的自然的质量，是指某一种生命就生物学角度讲是否具备作为人的基本要素，从医学上说主要指智能和体能两个方面的评价。

（2）生命质量的指标：健康程度，治愈希望，预期寿命，智力状况。

3、生命值的含义

（1）生命价值，主要是从人的社会学角度，判断某一个体生命对他人以及社会的意义。

（2）生命价值观是主张以人对他人和社会的作用及意义的大小为标准，有效的控制人口数量及质量，以保证人类和谐生存与发展的生命观及理念。

4、历史意义：

（1）使医学价值观更深刻、更合理。

（2）使医学伦理学的研究方法更进步、更科学

（3）为化解当代医学道德难题铺垫了理论基础

5、生命价值与质量观的内容及主要特征：

（1）人类可以根据整体利益，有条件的而且是人道的干预人的生命的过程；

（2）应当从社会公共利益和长远利益出发，来判断生与死的价值；

（3）对病人的责任与对社会的责任的统一；

（4）局部利益与整体利益的统一；

（三）义务论（又称为道义论）

（一）道义论概述

1、含义：

道义论（Deontology），指对一个行为的正、误的评价不在于诉诸行为的后果，而在于规定伦理道德的原则或规则，而有些原则或规则是不管后果如何都必须贯彻的。

2、分类及理论的基本原则



Hmaide

（四）后果论和功利论

（一）概述

1、含义：主张判断人的行为在伦理上正误的标准要看行为的效用

2、分类及基本观点：

（二）对效果论的评析

（1）关于功利论中的快乐标准

（2）行为功利论在实践中的理论难题

（3）规则功利论在实践中的理论难题

（五）公益论和公正论

（一）概述

1、含义：公益论强调社会公众利益，公正论强调卫生资源的分配。

2、两个理论的产生是社会发展的必然结果。

（二）主要内容：

1、公益论的内容

兼容观、兼顾观、社会效益观：

2、公正论的主要内容：

保障基本权利、按需分配、福利性和商品性相结合

一、医学伦理学的基本原则

（一）基本原则的含义

是指反映某一医学发展阶段及特定的社会背景之中的医学道德地根本精神，调节各种医学关系都需遵循的根本准则和最高要求。

（二）基本原则的内容

防病治病、救死扶伤、实行社会主义的医学人道主义、全心全意为人民健康服务。

二、医学伦理学的具体原则

（一）尊重与自主

1、尊重原则

狭义讲,医患双方交往时应该真诚地尊重对方的人格,并强调医务人员尊重病人及其家属的独立而平等的人格与尊严。

广义讲,除尊重病人的人格外,还包括尊重病人自主权。

2、自主原则。 医师尊重病人的自主性,保证病人自己做主、理性地选择诊治决策的伦理原则。

医方代替患者做主的两种情况

1、全权做主,指在选择重大医疗决策时,事先不征求(不能征求或不宜征求)病人意见,而由医方全权代替病人做决定。

2、半权做主,指在选择重大医疗决策时,先征得病人或其家属同意,或者先征得病人或其家属授权,然后由医方代替病人做决定。

当遇到下列情况时,医方做主既是合理的,又是必需的:

(1) 病人病情十分危急,需要立即进行处置和抢救,因而来不及知情同意;

(2) 病人患“不治之症”,本人或其家属将治疗权全权授予医生;

(3) “无主”(身边没有任何人代行其自主权)病人需要急诊急救,而本人不能行使自主权;

(4) 病人患有对他人、社会有危害的疾病而又有不合理要求和做法

（二）有利和不伤害原则

1、有利原则

把有利于病人健康放在第一位并切实为病人某利益的伦理原则。

《日内瓦宣言》明确规定:在我被吸收为医学事业中的一员时,我严肃的保证将我的一生奉献于为人类服务。我的病人健康将是我首先要考虑的。

2、不伤害原则

(1) 不伤害原则的含义:指在诊治护理的过程中,医务人员的医疗行为,其动机与结果均应避免对患者的损伤。这是医疗的底线原则。

(2) 不伤害原则的意义:不在于消除任何医疗伤害(这样的要求既不现实,又不公平),而在于强调培养为病人高度负责、保护病人健康和生命的医学伦理理念和作风,正确对待医疗伤害现象,在实践中努力使病人免受不应有的医疗伤害。

（三）知情同意和保密

1、知情同意原则:

向病人提供真实、充分的病情及治疗信息。

2、保密原则

保护病人的隐私权。

但保密不是绝对的义务。

两种例外:

(1) 继续保密对确定的第三者的生命健康造成严重威胁;

(2) 继续保密对公共卫生造成危害:危害公众的概率高,危害公众的数量大,危害与确定的人群有关

（四）公正与互助

医学服务公正观,应该是形式公正与内容公正的有机统一。

公正的伦理学依据:

(1) 病人与医师(患方与医方)在社会地位、人格尊严上是相互平等的;

- (2) 病人虽有千差万别，但人人享有平等的生命健康权和医疗保健权；
- (3) 病人处于医患交往双方中的弱势地位，理应得到医学所给予的公平、正义的关怀。

临床上，公正原则针对微观医药卫生资源分配，要求医方依次按医学标准——社会价值标准——家庭角色标准——科研价值标准——余年寿命标准综合权衡，在比较中进行优化筛选，以确定稀缺医药卫生资源优先享用者资格

13. 医学道德范畴：权利与义务，情感与理智，良心与荣誉，胆识与审慎；

14. 医学伦理学的基本要求：

尊重（自主）原则、有利（行善）原则、不伤害原则、公正与互助原则

15. 医学伦理学的应用原则：

知情同意原则、医疗最优化原则、医疗保密原则、生命价值原则

16. 医疗最优化原则：

疗效最佳、损伤最小、痛苦最轻、耗费最少

17. 医学道德规范：

医学道德规范是指依据一定的医学道德理论和原则而制定的、用以调整医疗人际关系、平价医学行为善恶的准则。

作用：

在医学伦理学准则体系中的主体作用

在医学道德评价中的尺度作用

在医院管理中的规范作用

在医学道德修养的内化作用

基本内容：

- 1、以人为本、践行宗旨
- 2、遵纪守法、依法执业
- 3、尊重患者、关爱生命
- 4、优质服务、医患和谐
- 5、廉洁自律、恪守医德
- 6、严谨求实、精益求精
- 7、爱岗敬业、团结协作
- 8、乐于奉献、热心公益

第三章 健康伦理

18. 健康概念的历史沿革

(1) 健康的消极概念：人体生理机能正常，没有缺陷和疾病

(2) 健康的生物学概念：“健康是人体正常功能活动，是人体统计学的正常状态”

(3) 科学健康的积极概念：健康不仅是没有疾病和虚弱的现象，而且是身体上、精神上与社会上的完好状态。

19. 健康道德的实质

(一) 医学道德向社会道德的扩展

(二) 医学道德向社会公德的升华

20. 健康道德的基本原则和具体原则

(1) 基本原则：人人健康、人人参与。

(2) 具体原则：

1. 知识性原则

2. 整体性原则

3. 协调性原则

21. 全人类的健康伦理责任

—环境污染的全球性；

—传染病流行已成为全球性的；

—贫富差距悬殊是全球性。；

—医疗技术、医疗资源全球发展分布不均

(一) 健全国际组织，制定国际规则

(二) 遵守合约、规则，共担责任、义务

(三) 帮贫扶弱，济难救危

(四) 交流互惠，共享成果

22. 全球环境问题产生原因

(1) 片面追求经济价值忽视生态价值引起的环境问题。工业发展产生的工业废水、废气、废渣引起的污染；

(2) 植被的迅速减少引起的环境问题。为了保证经济的高速增长而不惜以牺牲环境为代价，过度地开垦，使土地退化异常严重。

(3) 城市发展而引起的环境问题。一系列的由于城市发展环境问题给人们生活生产带来诸多不便。

23. 国家的健康伦理责任

(一) 确立正确的健康价值观(向公民进行健康和健康伦理学知识的普及传授)

(二) 确立有利于人民健康的执政理念,制定有利于健康的政治经济文化制度

(三) 制定促进人民健康的医疗卫生制度,主导医疗卫生工作

(四) 履行国际承诺,参与全球合作

24. 医疗卫生界健康伦理责任

(一) 积极开展健康指导

(二) 扩大城乡医疗卫生服务

25. 社会成员的健康伦理责任

(一) 学习健康知识,树立科学的健康观念

(二) 传播健康知识,倡导健康行为

(三) 用自己的本职工作,去维护和促进自己与他人的健康

(四) 同危害健康的言行作斗争,制止危害健康的事件的发生

26. 亚健康的个体表现(多选题)

(1) 身体亚健康

(2) 心理亚健康

(3) 情感亚健康

(4) 思想亚健康

(5) 行为亚健康

27. 产生亚健康的主要原因

(1) 亚健康源于越来越恶劣的社会生活环境。

(2) 亚健康源于越来越紧张的生存发展压力。

(3) 亚健康源于越来越倾斜的生活运动方式。

28. 走出亚健康的主要原则、方法:适度、乐观、和谐的基本原则

第四章 公共卫生伦理

第一节 公共卫生伦理概述

• 公共卫生的内涵及特征

(1) 内涵:由政府、社会或社区采取的旨在通过改善社会条件来促进人群健康,预防和控制疾病在人群中流行的干预措施

(2) 特征:政府是公共卫生的核心

(3) 政府在道德上的和政治上的权威和义务来自以下情况:

1) 合理的公共卫生干预的情况发生于公众健康收到了威胁

2) 合理的公共卫生干预的情况,发生对公共卫生的某个方面政府拥有独一无二的能力和专业人员时

3) 可以证明公共卫生干预是合理的,是当政府的行动是更为有效或者更为可能有效的干预时

(4) 公共产品:非竞争性非排他性

(5) 对公共卫生活动的道德和政治职权合理性证明是:

① 存在对群体广泛的健康威胁

② 拥有独特的政府权力和公共卫生基本领域的重要专家队伍

③ 要求政府行为更充分有效地保护公众健康

• 公共卫生伦理与原则

(1) 发生以下情况,违反上述权利可以被认为是正当的:

① 有紧迫的社会需求

② 公共卫生目标合理地服务于公众的利益

③ 对人权的限制在最低限度,而且没有其他可供选择的方法使对人权的限制更少

④ 采取的措施与公共健康问题的严重性成比例

⑤ 采取的措施是法律所允许的

(2) 公共卫生伦理的原则:

① 使目标人群收益

② 避免、预防和消除对他们的伤害

③ 受益最大化(效用主义原则)

④ 分配公正

⑤ 尊重自主的选择和自主行动

6 保护隐私和保密

7 遵守诺言和承担义务

8 信息的透明和告知真相

9 建立和维持信任

证明合理的条件：有效性、相称性、必要性、无害性、透明性

第二节 卫生政策的伦理依据、原则与实践

（一）卫生政策的现实基础与伦理依据

卫生政策是国家为改善人民的健康状况，维护人民的健康利益和权利而确定的一定时期的卫生保健目标和任务，以及控制使用、优化配置和公正分配卫生资源的战略方针与根本措施。

（1）卫生政策的现实基础：

现实的医学基础

医学目的和任务的转变(疾病构成及致病原因的变化、广大群众的健康需要)

医学高新技术的应用

（2）现实的社会基础：

市场经济体制

人民群众健康需求的增长

（3）卫生政策的伦理依据：

尊重生命的人道主义理论

社会公正论和公益论

义务论与效用论的结合

（二）卫生政策的伦理原则：

公正与公益的原则

公平与效率统一原则

责任分担原则

政府与市场结合原则

民主与公开的原则

公平基本内容：

保障社会成员的基本权利，首先是生存权和健康权（底线）；

机会平等（前提和基本保障）；

按照贡献分配（体现对个人劳动和自身价值的平等尊重）；

社会调剂是对一次分配后的利益格局进行的必要调整，已使社会成员能够普遍分享社会发展带来的收益（一致性）；

（三）卫生发展与改革的实践

（1）2009 年五点改革：

加快推进基本医疗保障制度建设；

初步建立国家基本药物制度；

健全基层医疗卫生服务体系；

促进基本公共卫生服务逐步均等化；

推进公立医院改革试点；

（2）新医改的基本原则：

坚持以人为本，把维护人民健康权益放在第一位；

坚持立足国情，建立中国特色医药卫生体制；

坚持公平与效率统一，政府主导与发挥市场机制作用相结合；

坚持统筹兼顾；

（3）深化改革的卫生发展战略包括：

1) 坚持医疗卫生事业的公益性质；

2) 强化政府责任，坚持政府主导与引入市场机制相结合；

3) 积极推进卫生保荐制度建设：

建设覆盖城乡居民的基本卫生保健制度

建设多层次的医疗保障体系

建立国家基本药物制度

建立科学规范的公立医院管理制度

4) 加强公共卫生体系建设，提高预防保健和疾病控制水平“预防为主”；

第三节 预防保健伦理

（1）预防保健的目标和特点：

特点：社会性、多学科性、群体性

（2）预防保健工作者的道德责任

热爱本职，敬业乐业

认真负责，实事求是

积极宣传，主动服务

团结协作，遵纪守法

（3）农村、社区卫生服务的伦理要求：

大力发展农村医疗卫生服务体系

加强完善社区医疗卫生服务体系

提升空间：

1）加强领导，完善政策

2）加强队伍建设，改善人才结构

3）加大力度，加快推进市级区域卫生信息平台建设

4）拓宽渠道，进一步提升社区卫生服务水平

（4）农村、社区卫生服务的道德要求：

尊重科学；无私奉献；高度负责；文明服务；团结协作

（5）深入开展爱国卫生运动

加强健康教育和健康促进

坚持预防为主，防治疾病

大力推进建立科学文明健康生活方式

第四节 艾滋病等传染病防控伦理

伦理要求：

- 积极开展传染病的防控，对广大群众的健康负责
- 认真做好传染病的检测和报告，履行其道德和法律责任
- 尊重科学，具有奉献精神
- 尊重传染病患者的人格和权利

医疗机构和医务人员在艾滋病防治中的伦理责任

- 加强宣传教育，普及预防艾滋病知识，提高公众自我保健意识，增强防御疾病、促进健康的能力
- 尊重艾滋病感染者和艾滋病病人的平等医疗权、隐私权

- 强化血液、血制品管理，防止医源性感染
- 认真做好艾滋病监测和检测工作，提高感染者的掌握率，及时、准确、全面掌握艾滋病疫情和流行趋势，为防治决策提供科学依据
- 积极开展艾滋病防治科学研究

突发公共卫生事件的伦理要求

- 恪守职责和加强协作，发扬敬畏生命的人道主义精神
- 树立崇高的职业责任感和科学态度
- 勇于克服困难，具有献身精神

第五节 生态保护伦理

（1）全球生态危机

全球气候变暖；臭氧层破坏；生物多样性减少；水资源危机；空气污染；重金属污染；食品安全危机

（2）作为医务人员，应遵守：

- 转变观念，尊重自然，与自然为友
- 从我做起，保护自然，降低人类活动对生态环境的影响和压力
- 积极宣传教育，提高全民保护生态环境的意识
- 自觉遵守环境保护的法律法规
- 支持和维护保护生态环境的言行，批评和抵制破坏生态环境的言行

第五章 医疗人际关系伦理

第一节 医患关系伦理

狭义的医患关系是指个体（医生）和个体（患者）之间的相互关系

广义的医患关系是指群体（医方）和群体（患方）之间的关系。

一、医患关系的特点：

- 明确的目的性和目的的统一性
- 利益的相关性和价值实现的统一性
- 人格权力的平等性和医学知识的不对称性
- 医患冲突的敏感性和不可避免性

二、医患关系的模式

- 医患关系是以诚信为基础的。诚信是医患关系的基石

- 医患关系具有医疗契约的性质
- 医患关系是一种信托关系

医患关系的模式

模式↕	医生的地位↕	患者的地位↕	模式应用对象↕	生活↕ 原型↕
主动－被 动↕	为患者做什么↕	被动接受↕ (无反应能力)↕	昏迷、全身麻醉 后、休克病人↕ 以及婴幼儿↕	父母与婴儿↕
指导－合 作↕	告诉患者做什 么↕	合作↕	病人清醒，有感 觉和自我意志、 主动寻医↕	父母与青少年↕
共同参与↕	帮助患者自疗↕	伙伴关系(主动 参与全过程)↕	慢性疾患的病人 和心理治疗↕	成人之间↕

三、医患双方的权利与义务

（一）医方的权利与义务

1. 医方的权利：P109
2. 医方的义务：
 - 医师对患者的义务：
 - 严格遵守规章制度和技术操作规程的义务
 - 如实记载和妥善保管病历的义务
 - 如实告知和说明的义务
 - 抢救和转诊的义务
 - 尊重和保护患者隐私的义务
 - 医师对社会的义务：
 - 开展预防保健的义务
 - 提高人类生命质量的义务
 - 参加社会现场急救的义务
 - 发展医学科学事业的义务

（二）患者的权利和义务

患者的权利：

- ①基本医疗权
- ②知情同意权
- ③隐私保护权
- ④经济索赔权
- ⑤医疗监督权
- ⑥医疗选择权
- ⑦社会免责权
- ⑧照顾和探视权

患者的义务：

- 保持和增进健康的义务
- 配合诊疗的义务
- 遵守医院规章制度，尊重医护人员及其劳动的义务
- 给付医疗费用的义务

四、调适医患关系的道德要求

- （一）尊重理解的原则
- （二）求同存异的原则
- （三）诚实守信的原则
- （四）依法调适的原则

第二节 医际关系伦理

医际关系的含义：指在医疗活动中不同医务人员之间所形成的业缘关系，包括医师与医师之间、医师与护士之间、医师与医技人员之间，以及护士与护士之间、护士与医技人员之间的关系等

一、医际关系的特点

- 主导性与平等性的统一
- 协作性与竞争性的统一
- 差异性与同一性的统一

协调医际关系的道德要求

二、协调医际关系的道德要求

（1）医师之间关系的道德要求

- 尊重同道，彼此信任
- 取长补短，互相学习
- 精诚合作，互谅互让
- 求同存异，公平竞争

（2）医师和护士之间关系的道德要求

- 主导-从属型
- 并列-互补型
- 相对独立型：
互相支持，合作互补
主动协作，互相监督

（3）医师与医技人员之间关系的道德要求

- 正确认识，互相尊重
- 互相支持，共同提高
- 彼此加强监督，确保技术适宜

三、协调好医技关系的意义

1. 当代医学发展的客观需要
2. 有利于整体效应的发挥
3. 有利于医务人员的成长
4. 有利于和谐医患关系的构建

第三节 患际关系伦理

一、患际关系的含义及特点

（一）患际关系的含义

所谓患际关系，就是临床工作中患方与患方之间的关系，包括患者与患者之间的关系、患者与其家庭的关系、患者家属之间的关系等

（二）患际关系的特点

同感共情性

效应累加性

利益竞争性

二、协调患际关系的道德要求

1. 平等待患，一视同仁
2. 诚实守信，公正公开
3. 培育典范，积极引导

三、协调好患际关系的意义

1. 有利于促进医患关系的和谐
2. 有利医疗服务质量的提高
3. 有利于医院良好形象的树立

第六章 临床诊疗伦理

29. 临床诊疗的伦理原则

- （一）患者至上的原则
- （二）最优化原则
- （三）知情同意原则
- （四）保密守信原则

30. 患者至上的伦理原则在临床中具体表现为：

- ..在询问病史的过程中语言亲切, 通俗易懂
- ..在辅助检查中要从诊治需要出发, 不做无关检查
- ..在手术治疗中要高度负责, 一丝不苟
- ..在检验工作中要急病人所急, 尊重病人

最优化原则

1. 内涵

在临床诊疗中指诊疗方案要以最小的代价获得最大效益的决策原则，也叫最佳方案原则。

2. 内容

- （1）痛苦最小
- （2）效果最好
- （3）安全度最高
- （4）耗费最少

2. 知情同意原则：

意义：

- ① 它是尊重病人自主权的集中体现
- ② 它是建立现代新型医患关系的必要条件
- ③ 有利于避免和减少医疗纠纷

贯彻知情同意原则应注意的几个问题

- （1）要使病人或其家属完全知情
- （2）要确保病人或其家属的同意必须是有效的

病人具有自由选择的权力（包括随时收回、终止或改变其承诺的权力），表达承诺的合法权力（符合法定的责任年龄和责任能力）

知情同意的例外如：保护性医疗、急危重症的处理、传染病、瘾君子等。

保密原则包括三方面的含义：

- 其一，为患者保密
- 其二，对患者保密
- 其三，为医院和医务人员保密

31. 临床诊断：是医生通过采集病史、体格检查及各种辅助检查等措施，收集患者的病情资料，然后将资料进行整理、归纳和分析，从而做出概括性判断的过程。

第一节

（一）询问病史

1. 举止端庄，态度和蔼
2. 全神贯注，语言担当
3. 耐心倾听，正确引导
4. 仔细严密，收集完整

（二）体格检查

1. 尊重患者，心正无私

2. 全面系统，认真细致
3. 关心体贴，减少痛苦

（三）辅助检查

1. 医生应遵循的伦理要求

- （1）综合考虑，确定检查项目，目的纯正
- （2）权衡利弊，注重知情同意，医生尽职尽责
- （3）全面分析检查结果，避免主观片面

2. 医技人员应遵循的伦理要求

- （1）严谨求实，严谨差错
- （2）工作敏捷，及时准确
- （3）精心管理，保证安全
- （4）发挥特长，加强协作
- （5）了解医技人员行为规范

第二节

（一）药物治疗

药物治疗是临床最常见的治疗手段，是促进和维护人类健康的有力工具，它不仅能控制疾病的发生发展，还能调整、提高人类的抗病能力。

1. 医务人员的伦理要求

- （1）掌握指征，剂量适宜
- （2）合理配伍，观察细致
- （3）用药科学，兼顾远近
- （4）节约资源，工作分配

2. 药学技术人员的伦理要求

- （1）审方认真，调配迅速，坚持查对
- （2）操作正规，称量准确，质量达标
- （3）忠于职守，严格管理，廉洁奉公
- （4）药学技术人员行为规范

（二）手术治疗的伦理要求

1. 手术前的伦理要求

- （1）必须严格掌握手术适应证，手术动机纯正
- （2）必须选择最佳术式
- （3）必须做到知情同意
- （4）必须做好术前准备

2. 手术中的伦理要求

- （1）关心患者，体贴入微
- （2）不抢手术，不滥施手术
- （3）严肃认真，一丝不苟
- （4）齐心协力，操作规范
- （5）不垄断手术，不推卸手术

3. 手术后的伦理要求

- （1）密切观察，勤于护理
- （2）减轻痛苦，加速康复
- （3）正确对待事故差错

（三）心理治疗

1. 掌握知识，运用技巧
2. 了解心理，尊重需要
3. 诚实守信，真诚相待
4. 正确疏导，灵活施治
5. 保守秘密，巧讲真话
6. 保持心态，注重“慎独”

（四）饮食营养治疗

1. 确保饮食营养治疗的科学性和安全性
2. 创造良好的进餐环境和条件
3. 尽量满足患者的因素习惯和营养需求

第三节

一、临床急诊的伦理要求
争分夺秒，果断采取措施
敢于负责，勇于承担风险
技术精湛，严守规章程序
密切配合，多方通力协作
高度警觉，精心细致严谨
体贴患者，重视心理治疗
全面考虑，维护社会公益

二、妇产科的伦理要求

弘扬奉献精神，勇于承担责任
积极主动应对，及早做好防范
尊重患者需要，体贴入微服务
严肃庄重保密，动作轻柔准确
慎重选择用药，严格手术指征
杜绝性别鉴定，禁止非法堕胎

三、儿科的伦理要求

热情亲切，关心体贴
高度负责，细心观察
谨慎用药，精心治疗

四、老年医疗工作的伦理要求

尊重患者，优质服务
高度重视，相信治疗
优选方案，知情同意
关注心理，加强沟通

五、精神疾病诊疗的伦理要求

尊重患者，注意保密
优选方案，合理治疗

遵循规范，自尊自爱
正直无私，恪守审慎

六、传染病诊断与治疗伦理要求
诊断要准确、既是，增强责任与保健意识
要重视消毒隔离，严防疾病扩散
不怕传染危险，真情无私奉献
加强心理疏导，减轻心理压力

七、检验和病理科医务人员的伦理要求
严肃认真，加强管理
实事求是，客观真实
尊重患者，注重时效

八、影像科和核医学人员的伦理要求
（一）影像科医务人员的伦理要求
1. 加强沟通，高度负责
2. 加强防护，优化利用
3. 举止端庄，尊重人格
（二）核医学医务人员的伦理要求
1. 正确选择坚持方法，合理使用放射药物
2. 科学进行技术操作，正确评价检查结果
3. 严格执行规章制度，有效防止环境污染

第四节

一、过度医疗是指在医疗活动中，由于多种原因所引起的医疗机构和医务人员提供超过疾病诊疗实际需要的医疗服务。
（一）过度用药
（二）过度检查
（三）过度治疗

二、过度治疗的特征
诊疗手段超过疾病的实际需要；
诊疗未能符合疾病的特点和诊疗规范；
所提供的医疗服务超出个人、家庭和社会的经济承受能力；
所提供的医疗服务无利于患者的生理和心理健康，甚至造成损害；

三、过度医疗的伦理分析
（一）过度医疗违背医学伦理公正公平使用医疗资源的原则
（二）过度医疗违背医学伦理最优化和有利不伤害原则
（三）过度医疗违背医学伦理知情同意和自主的原则
（四）过度医疗违背医学伦理病人健康第一的原则

四、解决过度医疗问题的措施
（一）预防观念
（二）支付制度
（三）持续改进
（四）专业自治
（五）伦理法律监督

第五节

以“全面康复”为主要原则，以“重返社会”为最终目的。
康复医学的伦理意义
（一）康复医学着眼于恢复伤、病、残者的身体功能，提高其生活自理能力和社会活动能力，体现了以人为本的现代人权观念；
（二）康复医学为社会节约了大量开支，为社会经济进步做出了贡献；
（三）康复医学能大大减轻家庭负担，有利于促进社会的稳定；
（四）康复医学有利于促进社会文明的进步，有助于和谐社会的构建。

康复诊治的伦理要求

- 确立康复目标
- 动态优化康复治疗方案
- 尊重与理解，关怀与帮助
- 团结与协作
- 明确和强调家庭照顾责任

第七章 护理伦理

记得这一章考了不少~~~

- 第一节 护理伦理与临床护理工作
 - 临床护理伦理
 - （1）护理伦理道德概述（P161）
 - （2）护理伦理道德的作用
 - 护理道德是完成护理工作的重要保证
 - 护理道德是提高临床医疗和预防疾病质量的重要条件
 - 护理道德对推动整个社会精神文明建设起着重要作用
 - 护理道德是护理人员自身素质完善的根本要素（政治思想道德素质、科学素质、心理素质）
- 临床护理工作的主要特点
 - 服务的广泛性
 - 严谨的科学性
 - 很高的艺术性
 - 极强的协调性
- 护士的形象和职业素质
 - 素质：思想道德素质、科学文化素质、专业技术（技能）素质、身心素质
- 护理工作中的伦理原则
 - 尊重患者，全心全意为患者服务的原则
 - （1）平等对待患者

- （2）全心全意，精心护理
- 拟定最佳护理方案，提供优质服务的原则
- 密切合作，协同一致的原则

第二节 基础护理、整体护理和心理护理伦理

一、基础护理道德（基本理论、基本知识和技能）

（一）基础护理的特点：

主要包括共性的生活护理、精神护理和技术操作

- 经常性
- 信息性
- 协调性
- 科学性

（二）基础护理的道德要求

1. 热爱专业，安心本职
2. 认真负责，一丝不苟
3. 团结合作，协同一致
4. 刻苦学习，精通业务
5. 严密观察，谨慎处理
6. 严格操作，按章行事

二、整体护理道德（P168）

整理护理的道德要求

1. 整体观念，协调统一
2. 周密分析，承担责任
3. 独立思考，积极主动
4. 刻苦专研，不断进取

三 心理护理道德

（1）心理护理的特点

- 需要关心和支持
- 需要同情与尊重
- 需要信息与安慰

- 需要安全与康复

（2）心理护理的道德要求

- 要有高度的同情心和帮助患者解决心理问题的诚意
- 要以高度的责任心了解和满足患者的心理需要
- 要以高度责任感为患者保守秘密和隐私
- 要以高度事业心努力创造一个有利于患者康复的环境

第三节 门、急诊护理与特殊护理

- 门、急诊护理道德

（1）门诊护理道德要求

特点：

病人多，工作内容繁杂

人群杂，预防交叉感染难度大

工作量大，针对性服务强

道德要求：

热情关怀、一视同仁

作风严谨、准确无误

密切协作、保护隐私

环境优美、安静舒适

（2）急诊护理道德要求

特点：

随机性大，必须常备不懈

时间性强，必须争分夺秒

病情多变，必须积极主动

道德要求：

争分夺秒，冷静配合

同情理解，关注患者

高度负责，团结协作

不断学习，技术精湛

（3）危重病人抢救中的护理道德要求

特点：急、重、险、危

护理道德：

果断与审慎

敏捷与严谨

机警与冷静

理解与紧张

慎独与协作

- 特殊护理道德

（1）特殊护理的特点

服务范围广

护理难度大

道德要求高

伦理难题多

（2）特殊护理的道德要求

1. 妇产科护理道德

特点：

服务对象的特定

心理状态的特别

工作性质的特殊

道德要求：

吃苦耐劳，勇于奉献

保护隐私，关注心理

严格观察，果断处置

小心谨慎，高度负责

2. 儿科护理道德

特点：

护理内容复杂、难度大；

预防交叉感染，任务重

道德要求：

体贴入微，治病育人
细致观察，审慎从事
认真负责，密切协作
积极沟通，精益求精

3. 精神病患者的护理道德

特点：

配合诊疗护理的困难多；
病房护理管理难度大；
治疗护理效果的反复性强

道德要求：

尊重患者；
保守秘密；
恪守慎独；
正直无私；
保证安全

4. 老年患者的护理道德

特点：

病情复杂，护理任务重；
病情多变，护理难度大
容易焦虑，心理护理要求高

道德要求：

真诚尊重，高度关怀
明察秋毫，审慎护理
护教结合，指导养身
了解家庭背景，共创敬老环境

5. 传染病患者的护理道德

特点：

传染性、流行性、季节性、地方性
传染病人的心理问题多；
传染病房护理管理难度大；
对传染科护理人员的道德要求高

道德要求：

尊重科学；
关注心理；
竭力救治；
预防为主。

第四节 社区医疗保健与家庭病床护理伦理

一、社区医疗保健中的护理伦理

1. 社区医疗保健的特点：

群众性
长期性
预防性
可及性

2. 社区医疗保健的内容

做好卫生宣传教育
预防疾病的发生
开展妇幼保健活动
治病防残，促进健康恢复

3. 社区医疗保健中的护理伦理要求

热情服务，礼貌待人
专研业务，不断提高
任劳任怨，真诚奉献

严于律己，公平公正

二、家庭病床护理中的伦理要求

1.家庭病床护理的特点

工作内容广发

护患关系密切

道德要求更高

服务“亲情化”“以人为本，患者至上”的服务理念

2.家庭病床护理的伦理要求

尊重人格，平等待人

勤奋学习，精益求精

遵守诺言，定时服务

言行谨慎，保守秘密

明确目标，密切协作

第八章药事伦理

所谓药事，即与药品的安全、有效、经济、合理、方便等相关的药品研究与开发、制造、采购、储藏、营销、运输、服务、使用等一系列活动。所谓药事伦理，就是从事上述工作所应具备的职业道德。

第一节 药品研制生产和销售中的伦理

一、药物研制的伦理意义及道德要求

（一）药物研制的伦理意义

是维护人民身体健康，提高人民生活质量的重要保证；

是促进医药事业发展，构建和谐社会的强大力量。

（二）药物研制的道德要求

高度强烈的社会责任

纯正崇高的研究动机

严谨求实的科学态度

勇于献身的革命精神

二、药品生产销售的伦理意义及道德要求

（一）加强药品生产销售环节道德建设的必要性和紧迫性

（二）药品生产销售的道德要求

- 坚持质量第一，保证药品的安全有效
- 注重社会效益，将人民群众的健康放在首位
- 加强行业自律，坚决抵制各种不良风气
- 保护生态环境，维护药品生产者的健康

第二节 药品使用中的伦理

一、防止发生药源性疾病的道德要求

所谓药源性疾病，是指药物引起人体不良反应并由此产生各种症状的疾病。药源性疾病的产生，一方面是由于药物本身的因素造成的，另一方面是由于使用不当造成的。因此，防止药源性疾病的产生，应当从药物研制生产和药物使用两方面加强道德建设：

（1）加强药物管理的道德建设

（2）加强药物使用的道德建设

（3）加强药物控制的道德建设

二、药品使用中的伦理责任

（一）不合理用药和滥用药物的伦理分析

滥用药物：“跟通常医疗实践不一致，或长期或偶然地超量使用与疾病无关的药物。在临床上被滥用的药物主要有抗生素、麻醉药、精神类药品、激素等。

不合理用药和滥用药物的后果十分严重：

- 首先，患者的生命健康受到伤害。
- 其次，药物尤其是抗生素的滥用导致了严重的生态问题。
- 不合理用药和滥用药物的原因主要有三方面：医生\病人\社会

（二）临床用药的道德要求：

（评价合理用药的 5 标准：有效，安全，方便，节约，中西药结合）

- 合理用药，严防药品乱开滥用
- 极端负责，确保用药安全有效
- 从长计议，减少药品不良反应
- 多方努力，提高药品治疗效果

（三）医院药剂工作的道德要求

- 1、认真审方，准确调配
- 2、反复核对，交代清楚

第三节 药品监督管理伦理

一、药品监督管理工作概要

药品监督管理是指各级药品监督管理行政部门依法对药品从研制生产到销售使用各个环节进行监督管理的工作。

在我国，药品监督管理的最高机构是国家食品药品监督管理局，主管全国药品监督管理工作，各级人民政府所设药品监督管理机构负责所辖范围内的药品监督管理工作。

（一）药品监督管理的特点

1. 预防性
2. 完善性
3. 促进性
4. 慎报性
5. 教育性

（二）药品监督管理工作的原则

- 以社会效益为最高原则
- 质量第一原则
- 法制化和科学化相统一的原则
- 专业监督管理与群众监督管理相结合原则

（三）药品监督管理工作的职责

P199

二、药品监督管理的伦理意义

1. 提高医药行业的管理水平
2. 促进医药行业的健康发展

三、药品监督管理的道德要求

药品监督管理可以分为两个方面：行政监督和技术监督

（一）药政人员的道德要求

- 1、严格执法，忠于职守
- 2、坚持原则，秉公无私
- 3、认真细致，严防疏漏

（二）药品检验人员的道德要求

- 1、严格检验，切实保证药品质量
- 2、勤学苦练，不断提高技术水平
- 3、清正廉洁，坚决抵制不正之风

第九章 生殖健康伦理

第一节 生育控制伦理

所谓计划生育，指的是对人口再生产过程进行有计划的调节，做到有计划地生育子女，也就是生育控制，即对人的生育行为进行社会控制

1798 年，英国的马尔萨斯发表《人口原理》，提出了影响深远的限制人口增长理论。

生育政策具体包括调节妇女生育数量，调整婚龄、育龄和生育间隔，采取避孕、节育措施，提倡优生等。

二、生育控制的伦理要求：

- 个体的生育权利必须与群体的历史发展相协调
- 生育数量必须与生育质量相协调
- 生育活动必须与资源环境相协调
- 生育行为必须与科技文化水平相协调
- 生育政策必须与人民群众的实际需要相协调

三、生育控制的伦理价值

- 更加有利于中华民族的生息发展
- 更加有利于构建人与环境的和谐关系
- 更加有利于提高人口素质
- 更加有利于提升生命质量
- 更加有利于人类进步发展

四、生育控制的伦理抉择

- 1. 生育不均
- 2. 素质不高
- 3. 性别歧视
- 4. 流动生育
- 5. 人口老化

五、计划生育工作中医务人员的伦理责任

- 1、确立科学的生育观、人口观
- 2、严格遵守执行计划生育法律法规
- 3、提供优质技术服务
- 4、贯彻知情同意原则
- 5、坚持尊重保护原则

第二节 优生学及其伦理反思

关于种族主义和阶层偏见
生殖自由问题
分配公正

第三节 产前诊断与遗传咨询

（1）医学遗传检测的伦理学考虑：

- 生殖遗传服务（RGS）不应该用于寻求“优生”的目的，但应该以增加个人对自己生育的控制为目的
- 生殖遗传服务的标准应该是重视信息、教育和咨询而不仅仅是检测程序
- 根据后果论的观点，对植入前遗传诊断的伦理学应该考虑在平等分配的情况下促进最大多数人的最大利益
- 应该具有减少医疗保健费用的潜在意义

- 具有创造更健康的社会的潜在意义，也就是说植入前遗传诊断的行为后果应该是更加健康的人
- 政府对该服务的控制和管理
- 防止歧视
- 基因检测纯属自由选择，绝不应强加个人

(2) 遗传咨询的伦理问题

- 1 非指令性咨询
- ②有利/不伤害
- ③数据保护:保密性、隐私性和自主性,防止歧视
- ④讲真话与不提供信息

如果求咨者家庭成员也有换严重遗传病的风险，是否应该违背保密义务告诉她/他？

告知的两种情况：

- 疾病是目前尚不可治疗的，但可被产前诊断出来
- 疾病是可以医治的，通过可得的安全的疗法能够治愈或大大减轻症状和并发症；或者如果在症状出现前检出可预防患病

第十章 临终关怀和死亡伦理

第一节

一、临终关怀的发展历史

1、临终关怀的含义

指对于临终病人及其家属所提供的一种全面照护，包括医疗、护理、心理、伦理和社会各个方面，使病人的生命质量得到提高。

2、临终关怀的历史发展

- ◆现代临终护理的创始人是英国的桑德斯(D. C. Saunders)博士，1967 年在英国伦敦创办了第一家临终关怀机构——圣克里斯多福关怀院。
- ◆真正意义上的临终关怀在 20 世纪 80 年代后期进入我国。1988 年天津临终关怀研究中心成立。1990 年第一家临终关怀医院上海南汇护理院成立。

二、临终关怀的现状与服务模式

“一、三、九—PSD 模式”：一个中心，三个方位和九个结合

一个中心：以解除临终患者的病痛为中心；

三个方位，九个结合：

服务层面上，临终关怀医院、社区临终关怀服务与家庭临终关怀病房相结合；

服务主体上，国家、集体和民营相结合；

服务费用上，国家、集体和社会投入相结合。

三、临终关怀的伦理意义

1. 当前推进临终关怀事业发展的迫切感

2. 临终关怀事业的发展事关重大民生问题

3. 临终关怀是关照千秋的事业

四、伦理要求

1. 认识和理解临终患者

2. 保护临终患者的权益

3. 尊重，满足临终患者的生活需求

4. 同情和关心临终患者的家属

五、临终关怀的发展趋势

- 加大临终关怀的支持力度成为全社会的责任
- 加强临终关怀学科建设成为发展临终关怀的动力
- 推广生命教育、死亡教育和临终关怀教育成为发展临终关怀的必需
- 政策支持成为临终关怀事业发展的保障
- 规范制度成为临终关怀的关键
- 减轻临终者的疼痛成为临终关怀的中心
- 心理关怀成为临终关怀的重点
- 建设专业队伍成为临终关怀的基础

第二节 死亡的概念

1. 全身死亡：传统对于死亡的理解，强调心肺功能不可逆的终止。

2. 脑死亡：是指作为整体的大脑功能的不可逆的终止。

著名的《哈佛标准》：1968 年，美国哈佛医学院特设委员会提出四条脑死亡的判断标准

- 没有感应性和反应性

- 没有运动和呼吸

- 没有反射（主要是诱导反射）

- 脑电图平直

- “深昏迷”：是指那些在脑结构上遭受了大面积不可逆损害的患者所处的一种状态。表现为对外部刺激完全没有反应，也没有自主呼吸；在他们的大脑表层和深层都测量不到生物电活动。

- 一般可将脑死亡的诊断标准归纳为以下五条：

①深度昏迷；②脑反射消失；③无自主呼吸；④脑电图平直；⑤脑循环停止。

5. 脑死亡的社会意义与存在问题

意义：

有利于减少卫生资源的浪费。

有利于充分利用卫生资源。

有助于解除家属的精神负担，捍卫患者死的尊严

问题：

对传统文化观念的冲击；

对现行法律制度的冲击；

实施中的可操作性问题。

第三节 安乐死概述

安乐死的基本条件：

◆对象：必须是而且只能是正在逼近死亡的绝症病人，被难忍的痛苦所侵袭

◆申请人：必须是患者本人，任何家属均不可代为申请，且病人有诚挚的愿望

◆实施主体：只能是受过正规培训，取得合法执业资格的医务人员，手段是医学手法

◆目的：只有一个，即解除病人痛苦

（一）道义论论证：安乐死违背了生命神圣的原则，违背了医生治病救人的基本义务。

（二）后果论论证：阻碍医学科学的进步。

（三）道德滑坡论证：一旦医生被允许干预患者自杀或者加速临终患者的死亡，会导致灾难性的后果。

实施原则：

- （一）患者利益原则：解除患者痛苦
- （二）公正原则：尊重每一个社会成员的权利
- （三）对极端社会功利主义安乐死观的批评
- 利他主义的安乐死：安乐死有利于家庭和社会
- 死亡“义务论”：选择死亡是权利，也是义务

第十一章 生命科技前沿若干问题伦理思考

第一节 器官移植的伦理

1. 活体捐献器官应遵守的伦理准则

- （1）捐献者必须具有完全民事行为能力的人
- （2）捐献者应在无任何外界压力的环境下明确地表示愿意捐献自己的特定器官；在器官被摘除前，捐献者有权随时撤回其意愿，且无须说明理由
- （3）捐献者应被告知器官摘除可能带来的后果和危险
- （4）应对捐献者进行全面体格检查，并能预料其捐献器官后健康仍有保障
- （5）所捐献器官应移植在指定的受体身上

2. 器官商品化的伦理问题

- （1）各国法律和国际伦理准则，都明确禁止器官买卖
- （2）器官买卖的弊端

3. 医务人员在器官移植中的道德责任

- （1）对活体捐赠者，应坚持医学标准，证明其身体器官是健康的，是可以作为移植用的，在移植手术过程中尽量避免或减少合并症。
- （2）捐赠者应在无任何压力、明确利弊和出于他利的情况下摘取器官。
- （3）应对捐赠者亲属告知实情，坚持亲属的知情同意原则。
- （4）应有 2 名以上医生在做出准确无误地判定死亡后，才能摘取捐赠者器官，并且抢救人员不得参与移植手术。
- （5）对器官的分配，应坚持医学标准和参照社会标准，尽量做到公正、公平地分配，使捐赠的器官能得到最佳的利用。
- （6）向接受者告知器官移植手术的风险，但为了保护接受者的利益，医务工作者应尽量争取移植手术的成功。
- （7）医务人员不得有意无意地参加有商业行为的器官移植活动。

（8）医师应履行医师的道德责任，并对供者、接受者和社会负责，减少因器官移植而引发的道德问题和医疗纠纷。

三、器官移植的伦理原则

- （一）病人健康利益至上的原则
- （二）唯一选择原则
- （三）自愿、无偿与禁止商业化原则
- （四）知情同意原则
- （六）保密原则
- （七）公正原则
- （八）伦理审查原则

第二节 人类辅助生殖技术伦理

1. 人类辅助生殖技术的伦理原则（人类精子库的伦理原则）

- 有利于患者的原则（有利于供受者的原则）
- 知情同意的原则
- 保护后代的原则
- 社会公益的原则
- 保密原则
- 严防商业化的原则
- 伦理监督的原则

2. 我国反对以克隆人为目的的任何实验和举动，主要是基于以下四方面的伦理考虑

- 克隆人是对人权和人的尊严的挑战
- 克隆人违反生物进化的自然发展规律
- 克隆人将扰乱正常的伦理定位
- 克隆人在技术上的安全性在伦理上难以确认

3. 人类胚胎干细胞研究遵循的伦理原则

- 建立鼓励对人类胚胎干细胞生物学基础研究的伦理准则
- 建立胚胎干细胞系的使用法规

- 将胚胎干细胞用于临床治疗的行动准则
- 制定胚胎干细胞用于人类疑难杂症的治疗的可能
- 建立和健全生命伦理委员会的审查、监控和评估机制

第十二章生物医学研究伦理

一、涉及人类受试者的生物医学研究的伦理论证

由于种属的差异性，动物实验并不能完全取代人体试验，虽然以人类为受试对象的医学研究对受试者而言是有风险的，不进行涉及人类受试者的生物医学研究和实验，也就没有所谓受试者的风险存在。

如果缺乏严格设计的科研/实验，就将其在临床上应用，必然导致一种无序而有风险的大规模“临床试验”

二、医学科研工作者的伦理要求

- 动机纯正，造福人类
- 尊重科学，诚实严谨
- 团结协作，公正无私
- 敢于怀疑，锐意创新

三、人体试验的基本伦理准则

- 维护受试者安康和权益的准则
- 以动物实验为前提准则
- 知情同意准则
- 为医学目的准则
- 实验对照准则

四、利益冲突问题

一、利益冲突的原因及表现

- 利益冲突会直接危及病人的利益和安康
- 利益冲突会使医生/研究者违背“优良临床实践的道德标准和科学标准”
- 利益冲突会使医疗行业中的信托关系和医生的诚信遭到破坏

二、利益冲突可以表现为：

- 医生/研究者的利益与病人/受试者利益的冲突
- 医生/研究者的物质利益与病人/受试者利益的冲突
- 医生/研究者的科研成就、学术前途与病人/受试者利益的冲突
- 医生/研究者本人的学术观点、政治倾向与宗教信仰和病人/受试者利益的冲突
- 单位（研究所，大学）利益与病人/受试者利益的冲突
- 企业的商业利益与受试者权益的冲突
- 利益冲突与医学杂志

三、利益冲突的解决方案

回避

公开

制订规则

教育与能力建设

第三节 伦理审查委员会与伦理审查

1. 伦理审查委员会的职能

教育职能、发展政策职能、咨询职能——保障人类受试者权益而服务

2. 意义：

伦理审查可以保障受试者在临床试验中的权益

伦理审查可以促进医学科学、生物科技研究的规范有序发展

3. 伦理审查的要求

- 尊重和保障受试者自主决定同意或者不同意受试的权利
- 对受试者的安全、健康和权益的考虑必须高于对科学和社会利益的考虑，力求使受试者最大限度受益和尽可能避免伤害
- 减轻或者免除受试者在受试过程中因受益而承担的经济负担
- 尊重和保护受试者的隐私
- 确保受试者因受试受到损伤时得到及时免费治疗并得到相应的赔偿
- 对于丧失或者缺乏能力维护自身权利和利益的受试者（脆弱人群）

4. 伦理审查的内容

第四节 基因诊断与遗传究中的伦理

1. 基因检测和诊断中的伦理问题

- 风险与收益
- 对家庭成员的责任
- 孩子的同意和利益冲突
- 隐私、保护和基因歧视

2. 遗传研究和开发中的伦理问题

- 遗传研究：样本的收集、储存和使用
- 人口遗传研究：群体同意
- 人类基因专利的问题

第十三章 医院管理伦理与伦理决策

第一节 医院管理伦理在现代医院管理中的地位和作用

一、医院管理伦理是现代医院管理的重要内容

医德医风与精神文明建设

核心价值观的培育与践行

医院伦理委员会建设

二、医院管理道德是医院管理者素质的核心组成部分

政治素质和道德素质（核心组成部分）

科学文化素质（手段）

身体素质和心理素质（基础）

第二节 医院管理伦理原则

1. 以服务对象为中心（医院及其医务人员与服务对象之间）

- 从“以疾病为中心”转变到“以病人为中心”
- 从“以医院及其医务人员为中心”转变到“以病人为中心”
- 从“以病人中心”到转变到”以服务对象为中心“

2. 以人为本（医院管理者与管理对象之间）

- 管理者应确立”管理服务“理念，热心为医务人员服务
- 医院管理者应该尊重被管理者的价值和尊严
- 医院管理者为人的全面发展创造条件

3. 经济收益适度（医院经济效益与社会效益之间）

- 注重社会效益，才能取得更好的经济收益
- 正确认识到医院是国家福利政策的载体
- 适度经济收益是医院发展的客观要求

4. 服务质量至上（服务质量管理与其他事务之间）

- 优良的质量永远是医疗服务的品质要求
- 视医疗服务质量为医院工作的生命线

第三节 医院管理的社会伦理责任和道德要求

一、医院管理的社会伦理责任

支持基层医疗机构

参加社会现场急救

参与社区卫生保健

注重预防工作

开展医德教育

二、医院管理者的道德要求

政治坚定、爱岗敬业

实事求是、改革创新

任人唯贤、人尽其才

民主管理、群策群力

合理竞争、诚实守信

公正廉洁、遵纪守法

第四节 医院伦理委员会的作用与建设

一、医院伦理委员会的概念和诞生背景

1983 年卡佛德和德奥德尔认为，医院伦理委员会是“由某个保健机构建立的、多学科职业人员组成的、为发生在该机构内的种种难题而设立的小组”

二、诞生背景：

1. 1. 生命医学的发展及新技术在临床的应用
2. 2. 卫生保健制度改革以及社会文化运动

三、医院伦理委员会的功能和作用

（一）建议咨询 （二）教育培训 （三）政策研究 （四）审查监督

四、医院伦理委员会的建设

- 充分认识建立医院伦理委员会的重要性和必要性
- 加强医学伦理委员会的组织建设
- 真正发挥其职能和作用

第五节 医疗伦理决策

一、医学伦理决策概论

（1）概念：医学伦理决策，是指医师基于医学伦理理论、原则和方法，确定诊疗目标，拟定、选择并最终确定诊疗方案的诊疗过程。

（2）医学伦理决策的基本过程

1. 确定合乎伦理的诊疗行为目标

首先，确定目标要基于病人的病情、医院及其医师的实际情况（前提）
其次，确定的诊疗行为目标应该是适宜的

2. 拟定多个合乎伦理的诊疗备选方案

3. 合乎伦理地实施诊疗行为方案

（3）医学伦理决策的模式

P325

二、医学伦理难题决策

（一）

含义：医师基于不同的伦理价值观，发现两种甚至两种以上不同程度冲突的医学伦理行为方案，对这种医学伦理行为决策的冲突问题，被称为医学伦理难题。

• 类型：

- ①高新医学技术引发的伦理难题和医疗卫生实践中的伦理难题
- ②具体医学伦理难题和抽象医学伦理难题

（二）医学伦理难题形成的原因

1、根本原因：“医学伦理关系的复杂化”和“利益的多样化”

2、具体原因：

高新医学技术的临床运用

医学伦理理论和原则的多样化

3、医学伦理文化的多元化

4、医药卫生体制和卫生法制的不断完善

（三）医学伦理难题的决策

1. 道德直觉与经验

2. 伦理前提和原则

- 正确进行医学伦理难题决策的根本伦理学理论是后果论

解决医学道德规范冲突的原则（①比较选择原则②分级量化原则③优先选择原则④必要害原则）

- 伦理协商与沟通

三、医学伦理决策的条件

- 医学伦理知识与技能
- 医学专业知识与技术
- 病人及其家属的价值观
- 法律、法规、规章和政策
- 规章制度与技术规范
- 医学伦理委员会

第十四章 医学伦理实践

第一节 医德评价和监督

一、医德评价的含义和作用

（一）医德评价的含义

评价是指对人或事物的价值判断； 医德评价是人们根据一定的医德标准，对医务人员或医疗卫生单位的职业行为和活动所做出的善恶褒贬的判断。

一般有两种形式：社会评价；自我评价。

（二）医德评价的作用

1. 对医疗行为的善恶起裁决作用
2. 对医德行为起调节作用
3. 对医务人员具有深刻的教育作用
4. 对医学科技的发展起促进作用

二、医德评价的标准

医德评价标准是指判断医学道德行为善恶以及行为者品德优劣的价值尺度，它是一定社会和医学背景下的医学道德要求。

1. 疗效标准
2. 科学标准
3. 社会标准

三、医德评价的依据（这个考过）

评价对象（医学行为或医德现象）提供给评价主体，用以与标准比较对照的根据

1. 动机与效果的统一
2. 目的与手段的统一

四、医德评价的方式

- （一）社会舆论
- （二）传统习俗
- （三）内心信念

五、医德评价的实施管理

- （一）普遍适用原则
- （二）全面规范原则
- （三）定性评价与定量评价相结合原则

（四）共同负责原则

（五）有效落实原则

六、医德监督

（一）医德监督的含义和作用

按照医德标准和原则，通过各种有效途径和方式，对医务人员履行医德规范的情况进行检查和监督，以帮助其树立良好医德风尚的活动。

1. 医德监督是加强医德医风建设的重要保证
2. 医德监督是培养医务人员良好品质的重要条件

（二）医德评价的方式

1. 法律监督
2. 舆论监督
3. 群众监督
4. 制度监督
5. 自我监督

（三）医德监督的原则

1. 综合监督原则
2. 坚持保证原则
3. 民主监督原则

第二节 医德教育

一、医德教育的含义与特征

（一）医德教育的含义：所谓医德教育，就是为使医学生与医务人员履行道德义务而对其有目的、有计划、有步骤、系统性地进行的医德灌输并施加医德影响的活动。

（二）医德教育的特征

1. 实践性
2. 长期性
3. 层次性

二、医德教育的目的与价值

有助于医务人员培养良好的医学职业精神

医德教育是培养德才兼备医学人才的重要途径

医德教育是推动医学科学发展的必要措施

三、医德教育的过程、原则与方法

（一）医德教育的过程

医德教育的过程就是医务人员医德品质下与发展的过程，由提高医德认识、陶冶道德情感、锻炼医德意志、确立医德信念和养成医德行为习惯 5 个环节构成，反映了医学道德教育的一般规律。

1. 提高医德认识
2. 陶冶道德情操
3. 锻炼医德意志
4. 确立医德信念
5. 养成医德行为习惯

医德教育的原则

1. 目的性原则
2. 正面疏导原则
3. 实践性原则
4. 主体性原则

（二）医德教育的方法

1. 理论与实践相结合
2. 典型示范与舆论扬抑相结合
3. 案例分析教育法

第三节 医德修养

一、医德修养的含义与意义

（1）医德修养是医德活动的重要组成部分之一，是医务人员通过自我培养和锻炼，将医德理论、原则规范转化为个人医德品质的过程，是一种重要的医德实践。

（2）医德监督的意义

1. 有利于深化医德教育
2. 有利于提高医务人员医德评价的能力
3. 有利于社会主义精神文明建设，形成良好的医德医风

二、医学道德修养的目标和伦理素质的养成

伦理素质的养成：1. 他律 2. 自律

三、医德境界的不同层次

1. 大公无私的医德境界
2. 先公后私的医德境界
3. 先私后公的医德境界
4. 自私自利的医德境界

四、医德修养的途径和方法

（一）医疗实践是医学道德修养的根本途径（单选）

1. 医疗实践是产生高尚医德的源泉
2. 医疗实践是检验医德修养效果的标准
3. 医疗实践是医德修养的目的
4. 医疗实践是推动医德修养的动力

（二）医德修养的主要方法

- 坚持医德理论与医疗实践结合
- 学习医德典范，从榜样中吸取力量
- 自觉地进行评判与自我批评
- 努力做到“慎独”
 - 1) 要提高“慎独”的自觉性
 - 2) 要在“隐”“微”之处下功夫
 - 3) 向更高的医德境界努力